



Doenças Orais e Nutrição em Gastroenterologia

A cavidade oral representa uma extensão funcional e fisiológica do trato gastrointestinal, sendo frequentemente o **primeiro local de manifestação** de doenças sistêmicas e gastrointestinais. O reconhecimento precoce de alterações orais constitui uma ferramenta diagnóstica de alto valor clínico para o gastroenterologista.

ESPECIALIZAÇÃO EM GASTROENTEROLOGIA

PARTE 1 — PÁGINAS 1-60

Introdução às Doenças Orais na Gastroenterologia

A cavidade oral e o trato gastrointestinal compartilham embriologia, mucosa contínua e mecanismos imunológicos semelhantes. Por isso, alterações orais frequentemente antecedem ou acompanham doenças do aparelho digestivo, tornando o exame da boca parte indispensável da avaliação gastroenterológica.

Doenças Inflamatórias Intestinais

A doença de Crohn e a retocolite ulcerativa produzem lesões orais específicas em até 20% dos casos, às vezes precedendo sintomas intestinais.

Deficiências Nutricionais

Carências de ferro, vitamina B12, folato e zinco manifestam-se precocemente na mucosa oral, oferecendo pistas diagnósticas valiosas.

Doenças Autoimunes

Síndrome de Sjögren, lúpus eritematoso e penfigóide têm expressão oral marcante, exigindo diferenciação cuidadosa.

Infecções Sistêmicas

Candidíase, herpes, HIV e sífilis produzem lesões características que orientam a investigação sistêmica.

📌 O reconhecimento precoce de alterações orais constitui uma ferramenta diagnóstica de alto valor clínico, reduzindo o tempo até o diagnóstico e otimizando o manejo terapêutico.

Classificação das Alterações Orais

Uma classificação sistemática das manifestações orais é essencial para organizar o raciocínio diagnóstico e direcionar a investigação complementar de forma racional. A abordagem estruturada reduz erros diagnósticos e evita procedimentos desnecessários.

1

Variantes Anatômicas Normais

Leucoedema, grânulos de Fordyce, pigmentação fisiológica — condições benignas que não requerem intervenção, mas devem ser reconhecidas para evitar alarme clínico desnecessário.

2

Transtornos da Mucosa Oral

Queratose friccional, xerostomia, glossite, síndrome da boca ardente — condições de origem variada que impactam qualidade de vida e podem indicar doenças subjacentes.

3

Lesões Pré-Malignas

Leucoplasia, eritroplasia, queilite actínica — lesões com potencial de transformação maligna que exigem biópsia e seguimento rigoroso.

4

Doenças Mucocutâneas

Líquen plano, pêmfigo, penfigóide — condições que afetam simultaneamente pele e mucosas, com mecanismos imunológicos bem definidos.

5

Manifestações Sistêmicas

Lesões orais de doenças gastrointestinais, hematológicas, endócrinas e infecciosas — representam a intersecção entre estomatologia e medicina interna.

Variantes Normais da Mucosa Oral — Importância Clínica

O reconhecimento das variantes normais da mucidade oral é uma competência fundamental para qualquer profissional que examine a boca. A falha em identificar essas condições benignas pode gerar uma cascata de consequências negativas para o paciente e para o sistema de saúde.

Por que reconhecer variantes normais?

- **Evitar diagnósticos equivocados:** lesões benignas podem ser confundidas com leucoplasia, candidíase ou outras condições patológicas por profissionais sem treinamento específico.
- **Prevenir biópsias desnecessárias:** procedimentos invasivos geram morbidade, custo e ansiedade sem benefício quando a lesão é fisiológica.
- **Reduzir a ansiedade do paciente:** a comunicação adequada de que a alteração é normal e não requer tratamento tem impacto direto no bem-estar psicológico.
- **Otimizar recursos:** o correto diagnóstico clínico evita encaminhamentos desnecessários e exames complementares sem indicação.

Abordagem Prática

Ao identificar uma variante normal, o clínico deve:

1. Confirmar as características típicas da variante (distribuição bilateral, ausência de sintomas, comportamento ao estiramento)
2. Registrar em prontuário com descrição detalhada
3. Orientar o paciente sobre a natureza benigna da condição
4. Estabelecer quando reavaliação seria necessária (mudança de aspecto, surgimento de sintomas)

❑ Em caso de dúvida diagnóstica, a biópsia é sempre preferível à observação de uma lesão potencialmente maligna.

Leucoedema

O leucoedema é uma das variantes normais mais frequentes da mucosa oral, estimando-se sua presença em até **50% da população geral**, com prevalência ainda maior em indivíduos de pele mais escura. Apesar de sua aparência que pode preocupar o não especialista, trata-se de uma condição completamente benigna.

Características Clínicas

- **Coloração:** branco-acinzentada ou esbranquiçada, com aspecto leitoso
- **Transparência:** semitransparente, lembrando névoa sobre a mucosa
- **Distribuição:** sempre bilateral, acometendo principalmente mucosa jugal
- **Sinal patognomônico:** desaparece completamente ao estiramento da mucosa — manobra diagnóstica essencial
- **Consistência:** sem espessamento palpável, superfície lisa

Fisiopatologia e Conduta

Mecanismo

O leucoedema resulta do **acúmulo intracelular de fluido** nas células do epitélio escamoso estratificado, causando edema e vacuolização das células das camadas espinhosa e granular. Esse acúmulo altera a refração da luz, criando o aspecto esbranquiçado característico.

Conduta

Nenhuma intervenção é necessária. O diagnóstico é exclusivamente clínico, baseado na manobra de estiramento. **Biópsia não está indicada** quando as características típicas estão presentes. Orientação ao paciente sobre a benignidade é suficiente.

Grânulos de Fordyce

Os grânulos de Fordyce são glândulas sebáceas ectópicas — ou seja, localizadas em região anatômica onde normalmente não existem glândulas sebáceas. São encontrados em até **90% dos indivíduos adultos**, representando uma das variantes normais mais prevalentes da cavidade oral. Não apresentam nenhuma relevância patológica.



Características Morfológicas

Pequenas pápulas de **1 a 2 mm** de diâmetro, com coloração branco-amarelada ou amarelada. Superfície levemente elevada, sem eritema perilesional. Distribuição caracteristicamente simétrica e agrupada.



Localização Típica

Preferencialmente na **mucosa jugal** (especialmente na linha de oclusão dental), vermelhão dos lábios, mucosa do lábio superior e, menos comumente, mucosa jugal inferior e palato mole.



Relevância Clínica e Conduta

Sem relevância patológica. O diagnóstico é clínico. **Nenhuma investigação ou tratamento é necessário.** A importância clínica reside em não confundir com candidíase pseudomembranosa, verrugas orais ou outras lesões que requerem manejo específico.

Pigmentação Fisiológica da Mucosa Oral

A pigmentação fisiológica da mucosa oral é uma variante normal especialmente prevalente em indivíduos de fototipos mais elevados (pele mais escura), sendo resultado do aumento da atividade melanocítica sem qualquer processo patológico subjacente. Seu reconhecimento é fundamental para evitar confusão com lesões pigmentadas de maior gravidade.

Características da Pigmentação Fisiológica

- **Mecanismo:** aumento da produção e deposição de melanina pelos melanócitos da camada basal do epitélio
- **Distribuição:** simétrica e bilateral, predominando na gengiva inserida (especialmente anterior superior e inferior)
- **Coloração:** variando de marrom-claro a marrom-escuro, podendo ser difusa ou em manchas
- **Bordas:** irregulares, mal definidas — característica que a diferencia de lesões neoplásicas, que tendem a ter bordas mais definidas
- **Superfície:** lisa, sem elevação ou ulceração

Diagnóstico Diferencial — Atenção!

É imperativo diferenciar a pigmentação fisiológica de condições patológicas:

- **Melanoma oral:** lesão assimétrica, crescimento rápido, ulceração, sangramento espontâneo — requer biópsia urgente
- **Mácula melanótica:** lesão solitária, bem delimitada, geralmente no lábio inferior ou gengiva — geralmente benigna mas requer acompanhamento
- **Doença de Addison:** hiperpigmentação difusa da mucosa oral associada a hiperpigmentação cutânea e sintomas sistêmicos
- **Pigmentação por medicamentos:** antimaláricos, minociclina e metais pesados podem causar pigmentação oral adquirida

❏ Qualquer lesão pigmentada nova, crescente ou assimétrica deve ser biopsiada para exclusão de melanoma.

Transtornos da Boca e da Língua — Visão Geral

Os transtornos da boca e da língua englobam um espectro amplo de condições com etiologias distintas — inflamatórias, traumáticas, infecciosas, nutricionais e neurológicas. Para o gastroenterologista, essas condições são de especial interesse porque frequentemente refletem doenças sistêmicas ou estados nutricionais deficientes que impactam o trato digestivo como um todo.

→ Condições Inflamatórias

Glossite, estomatite aftosa, síndrome da boca ardente — cursam com dor, eritema e alteração funcional da mucosa, podendo indicar doenças autoimunes ou deficiências.

→ Condições Traumáticas e Funcionais

Queratose friccional, úlceras traumáticas, xerostomia — resultam de agressão mecânica, química ou funcional à mucosa, com impacto na mastigação e deglutição.

→ Condições de Relevância Sistêmica

Manifestações orais de doenças gastrointestinais, hematológicas e endócrinas — constituem janela diagnóstica privilegiada para o gastroenterologista treinado.

O impacto funcional dessas condições é frequentemente subestimado. Dor oral, dificuldade de mastigação e alteração do paladar reduzem a ingestão alimentar, comprometem o estado nutricional e pioram a qualidade de vida — criando um ciclo vicioso especialmente relevante em pacientes com doenças gastrointestinais já comprometidas.

Queratose Friccional

A queratose friccional é uma resposta adaptativa do epitélio oral ao trauma crônico repetitivo. Representa a causa mais comum de lesão branca da mucosa oral e, ao contrário das leucoplasias, não apresenta potencial de transformação maligna quando o fator causal é removido.

Características Clínicas

- **Aspecto:** placas brancas ou esbranquiçadas, de superfície irregular, espessadas ao toque
- **Localização:** áreas de atrito habitual — linha de oclusão dental, mucosa jugal oposta a dentes fraturados ou restaurações inadequadas, borda lateral da língua, fundo de vestibulo
- **Bordas:** mal definidas, mesclando-se gradualmente à mucosa adjacente normal
- **Sintomas:** geralmente assintomática; pode haver leve rugosidade percebida pelo paciente

Histologia

O exame histopatológico revela **hiperqueratose sem displasia epitelial** — achado fundamental para diferenciação das lesões pré-malignas. A arquitetura celular é normal, com maturação ordenada das camadas epiteliais.

Diagnóstico Diferencial — Ponto Crítico

A queratose friccional deve ser rigorosamente diferenciada de:

- **Leucoplasia:** placa branca sem causa local identificável, com potencial maligno — requer biópsia
- **Líquen plano:** padrão reticular (estrias de Wickham), frequentemente bilateral, pode ser sintomático
- **Candidíase pseudomembranosa:** placas brancas removíveis à raspagem, associadas a imunossupressão
- **Leucoedema:** desaparece ao estiramento, sem espessamento

📌 **Ponto-chave diagnóstico:** a remoção ou correção do fator traumático leva à regressão completa da queratose friccional em 2 a 4 semanas. Se a lesão persistir após eliminação do trauma, biópsia está indicada.

Xerostomia — Conceito e Importância Clínica

A xerostomia é definida como a **sensação subjetiva de boca seca**, geralmente associada à hipossalivação (redução objetiva do fluxo salivar), embora possam ocorrer dissociadas. Trata-se de uma condição de alta prevalência, particularmente em idosos e em usuários de múltiplos medicamentos, com impacto significativo e frequentemente subestimado na saúde geral e na qualidade de vida.

Impacto na Digestão

A saliva inicia a digestão de amidos através da **amilase salivar** e facilita a formação do bolo alimentar. Sua redução compromete a primeira fase da digestão e sobrecarrega o estômago.

Predisposição a Infecções

A saliva contém **IgA secretora, lisozima, lactoferrina e histatinas** — proteínas com ação antimicrobiana. Sua redução favorece candidíase, cáries de progressão rápida e infecções bacterianas recorrentes.

Qualidade de Vida

Impacta diretamente a capacidade de falar, mastigar e engolir. Pacientes relatam dificuldade com alimentos secos, necessidade constante de ingerir líquidos e comprometimento do sono.

Relevância Diagnóstica

A xerostomia pode ser o **sintoma inicial** de doenças sistêmicas importantes como Síndrome de Sjögren, diabetes mellitus descompensado e infecção pelo HIV.

Etiologias da Xerostomia

A xerostomia tem etiologia multifatorial e seu correto diagnóstico etiológico é imprescindível para o tratamento eficaz. A causa mais prevalente na população adulta é o uso de medicamentos xerogênicos, com mais de 500 fármacos descritos como capazes de reduzir o fluxo salivar.

Medicamentos (Causa Mais Comum)

- **Antidepressivos:** tricíclicos (amitriptilina, imipramina) e ISRSs têm forte efeito anticolinérgico
- **Anticolinérgicos:** atropina, escopolamina, anti-histamínicos de 1ª geração
- **Anti-hipertensivos:** diuréticos, betabloqueadores, bloqueadores dos canais de cálcio
- **Antipsicóticos, ansiolíticos, opioides** — efeito dose-dependente

Doenças Sistêmicas

- **Síndrome de Sjögren:** destruição autoimune das glândulas salivares — principal causa de hipossalivação orgânica
- **Diabetes mellitus:** desidratação osmótica e neuropatia autonômica
- **HIV/AIDS:** infiltração linfocítica glandular (síndrome de Sjögren-like)
- **Doenças do tecido conjuntivo:** lúpus, esclerodermia

Outras Causas

- **Radioterapia de cabeça e pescoço:** fibrose e atrofia das glândulas salivares — efeito dose-dependente e frequentemente irreversível acima de 60 Gy
- **Desidratação:** causas clínicas variadas (diarreia, vômitos, febre, ingestão hídrica insuficiente)
- **Ansiedade e respiração oral crônica**
- **Envelhecimento:** redução fisiológica da função glandular

Manifestações Clínicas e Complicações da Xerostomia

Manifestações Clínicas

O espectro clínico da xerostomia é amplo e impacta múltiplas funções orais:

- **Dificuldade de mastigação:** alimentos secos tornam-se difíceis de mastigar e engolir sem auxílio de líquidos
- **Disfagia:** o bolo alimentar mal lubrificado causa dificuldade de deglutição, podendo levar à engasgação
- **Ardência oral e desconforto:** sensação de queimação difusa na mucosa, língua e lábios — frequentemente confundida com síndrome da boca ardente
- **Halitose:** redução do efeito autoclínico da saliva favorece proliferação bacteriana e produção de compostos sulfurados voláteis
- **Alteração do paladar (disgeusia):** a saliva atua como solvente de moléculas sápidas; sua ausência reduz a percepção gustativa
- **Dificuldade de fala:** a mucosa seca adere ao palato e lábios, prejudicando a articulação

Complicações — Alta Relevância Clínica

- **Candidíase oral:** a mais frequente; especialmente a forma eritematosa crônica, que passa despercebida; manifesta-se como eritema difuso, queilite angular ou placas pseudomembranasas
- **Cáries:** especialmente de progressão rápida, cervicais e de raiz — resultado da perda de tampão salivar e da proliferação de *Streptococcus mutans*
- **Lesões traumáticas:** a mucosa seca perde elasticidade e torna-se suscetível a ulcerações por trauma mínimo, como próteses dentárias
- **Infecções recorrentes:** parotidite bacteriana ascendente é complicação grave em pacientes hospitalizados com xerostomia severa

Síndrome de Sjögren — Introdução e Fisiopatologia

A Síndrome de Sjögren (SS) é uma doença autoimune sistêmica crônica caracterizada pela **destruição progressiva das glândulas exócrinas**, principalmente salivares e lacrimais, mediada por linfócitos T e B autorreativos. É a segunda doença reumática autoimune mais prevalente, afetando predominantemente **mulheres pós-menopausa** (relação feminino:masculino de 9:1), com prevalência estimada de 0,5 a 3% da população adulta.

Fisiopatologia

- **Infiltração linfocitária:** linfócitos T CD4+ e B infiltram progressivamente o parênquima glandular, formando agregados linfoides periductais
- **Destruição glandular:** o infiltrado inflamatório substitui o tecido secretor funcional por tecido fibroso, reduzindo progressivamente a capacidade secretora
- **Autoanticorpos:** anti-Ro/SSA e anti-La/SSB são os marcadores sorológicos clássicos, presentes em 60–70% dos casos; participam ativamente da lesão tecidual
- **Ativação do interferon tipo I:** via patogênica central, ativada por ácidos nucleicos endógenos liberados durante apoptose celular

Formas Clínicas

- **Sjögren primário:** doença autônoma, sem outra doença autoimune associada
- **Sjögren secundário:** associado a outras doenças autoimunes — artrite reumatoide (mais comum), lúpus eritematoso, esclerodermia, cirrose biliar primária

Relevância Gastroenterológica

O Sjögren pode acometer o trato gastrointestinal com manifestações de gastrite atrófica autoimune, disfagia esofágica por dismotilidade, hepatite autoimune e cirrose biliar primária associada — tornando o gastroenterologista um especialista frequentemente envolvido no cuidado desses pacientes.

Síndrome de Sjögren — Tríade Clássica, Manifestações Oraís e Diagnóstico

Xerostomia

Boca seca grave, frequentemente com ausência completa de saliva em repouso. Pacientes relatam necessidade de ingerir líquidos para engolir alimentos sólidos.

Xeroftalmia

Olhos secos com sensação de "areia nos olhos", fotofobia e lacrimejamento paradoxal. Risco de ceratoconjuntivite seca e lesão corneal.

Artrite

Artralgia ou artrite não erosiva, geralmente simétrica, acometendo pequenas e grandes articulações — diferente da artrite reumatoide, raramente causa erosões.

Manifestações e Complicações Oraís

- **Ausência de saliva:** mucosa oral brilhante, com aspecto "seco e pálido", língua sem saburra, ausência de saliva no assoalho bucal
- **Dificuldade alimentar grave:** incapacidade de ingerir alimentos secos; perda de peso e desnutrição em casos avançados
- **Lesões traumáticas recorrentes:** úlceras por próteses, fissuras nos cantos da boca (queilite angular)
- **Candidíase recorrente:** forma eritematosa predominante; resposta ao tratamento frequentemente incompleta pela hipossalivação persistente
- **Cáries de progressão rápida:** cervicais e generalizadas, devastadoras em pacientes jovens
- **Sialolitíase:** formação de cálculos nos ductos das glândulas salivares maiores pelo espessamento das secreções

Diagnóstico e Tratamento

Critérios diagnósticos (EULAR/ACR 2016):

- Biópsia de glândula salivar menor (foco score ≥ 1): 3 pontos
- Anti-Ro/SSA positivo: 3 pontos
- Teste de Schirmer ≤ 5 mm/5 min: 1 ponto
- Sialometria $\leq 0,1$ mL/min: 1 ponto

Tratamento:

- Estimulação salivar com goma de mascar sem açúcar e pastilhas de ácido málico
- Sialogogos: **pilocarpina** (5 mg 3x/dia) ou cevimelina
- Saliva artificial (carboximetilcelulose, mucinas)
- Controle da doença de base: hidroxiquina, rituximabe em casos graves

Glossite — Conceito, Causas e Manifestações

A glossite é definida como a **inflamação da língua**, podendo acometer o epitélio lingual superficial, as papilas filiformes e fungiformes, ou o parênquima mais profundo. Trata-se de um sinal clínico importante que pode refletir deficiências nutricionais, doenças sistêmicas ou condições locais, e não de um diagnóstico em si — a investigação etiológica é fundamental.

Principais Causas

- **Deficiência de vitamina B12 (cobalamina):** causa clássica de glossite atrófica; associada à anemia megaloblástica, especialmente em vegetarianos, veganos e pacientes com gastrite atrófica ou ressecção gástrica
- **Deficiência de ferro:** glossite no contexto de anemia ferropriva; comum em pacientes com sangramento gastrointestinal crônico
- **Deficiência de ácido fólico:** indistinguível clinicamente da deficiência de B12; ocorre em alcoolistas, gestantes e pacientes com má absorção intestinal
- **Alcoolismo crônico:** múltiplas deficiências associadas (B1, B2, B3, B6, B12, folato, zinco)
- **Doenças sistêmicas:** doença de Crohn, doença celíaca, síndrome de má absorção

Manifestações Clínicas

- **Glossodinia:** dor na língua, frequentemente de caráter urente ou latejante, exacerbada por alimentos quentes, picantes ou ácidos
- **Glossopirose:** sensação de queimação específica, podendo ser o sintoma predominante mesmo sem eritema visível
- **Eritema:** vermelhidão difusa ou em placas, refletindo atrofia das papilas e inflamação do epitélio
- **Atrofia papilar:** língua com aspecto "liso", sem as papilas filiformes normais — achado característico das glossites nutricionais
- **Fissuras:** em casos graves, surgem sulcos e fissuras na superfície lingual

❏ A glossite associada a deficiências nutricionais em paciente gastroenterológico deve sempre levantar suspeita de má absorção, sangramento oculto ou insuficiência dietética.

Tipos Específicos de Glossite



Glossite Atrófica

Caracterizada por língua lisa, eritematosa, com atrofia completa das papilas filiformes. O aspecto "glaceado" ou "envernizado" é patognomônico. Fortemente associada a **desnutrição, deficiência de B12, ferro e folato**. Pode ser o único sinal de anemia megaloblástica ou de má absorção grave.



Glossite Romboide Mediana

Placa eritematosa de formato oval ou romboide, localizada na linha média da língua, anterior à papila circunvalada. Histologicamente revela ausência de papilas e frequentemente hifas de *Candida*. A maioria dos casos está associada ao **tabagismo e ao uso de corticoides inalatórios**. Geralmente assintomática.



Língua Geográfica

Também denominada glossite migratória benigna, apresenta **áreas eritematosas bem definidas com bordas esbranquiçadas**, que migram ao longo da superfície lingual ao longo de dias a semanas, criando o característico aspecto em mapa. Condição benigna, sem potencial maligno. Pode causar dor com alimentos ácidos ou picantes. Tratamento com corticoide tópico quando sintomática.

Língua Pilosa Negra

A língua pilosa negra é uma condição benigna caracterizada pelo **alongamento e pigmentação das papilas filiformes** do dorso lingual, que podem atingir até 2 cm de comprimento (normal: 1–3 mm). Apesar do aspecto alarmante, trata-se de condição reversível após identificação e remoção dos fatores causais.

Fatores Precipitantes

- **Tabagismo:** o principal fator de risco; a nicotina e os compostos do tabaco promovem alongamento e queratinização excessiva das papilas
- **Antibióticos de amplo espectro:** especialmente penicilinas, tetraciclinas e metronidazol — alteram o microbioma oral, favorecendo o crescimento de fungos cromogênicos
- **Higiene oral precária:** acúmulo de bactérias e fungos pigmentados entre as papilas alongadas
- **Uso de enxaguatórios com peróxido de hidrogênio ou bismuto**
- **Xerostomia:** redução do efeito de limpeza salivar
- **Dieta pobre em fibras** e jejum prolongado

Diagnóstico e Tratamento

Aspecto clínico: papilas filiformes alongadas, com coloração que varia de amarelada a marrom-escura ou negra, dependendo das bactérias e fungos colonizadores presentes. Localização predominante na região central do dorso lingual.

Sintomas: geralmente assintomática; pode causar náusea, halitose e, raramente, sensação de engasgamento.

Tratamento

1. **Cessaç o do tabagismo** — medida mais eficaz
2. **Suspens o do antibi tico** causador quando poss vel
3. **Melhora da higiene oral:** escova  o suave do dorso lingual 2x/dia
4. **Raspagem lingual** com raspador espec fico
5. Antif ngicos se candidiase associada confirmada

Síndrome da Boca Ardente

A Síndrome da Boca Ardente (SBA) é uma condição crônica caracterizada por **sensação de dor ou queimação na cavidade oral sem lesão visível identificável** que justifique os sintomas. Afeta predominantemente mulheres na peri e pós-menopausa, com prevalência de 0,7 a 4,6% na população adulta. Representa um desafio diagnóstico e terapêutico pela sua fisiopatologia complexa e multifatorial.

Fisiopatologia

Envolve **disfunção neurosensorial** com alteração do processamento da dor nos níveis periférico e central. Há redução da densidade de fibras nervosas intraepiteliais, disfunção dopaminérgica e alterações autonômicas. Fatores hormonais (hipoestrogenismo) e psicológicos modulam a percepção dolorosa.

Apresentação Clínica

Queimação, dor ou formigamento em língua (especialmente ponta e bordas), lábios e palato. Os sintomas tipicamente **pioram ao longo do dia** e melhoram com alimentação ou distração — padrão inverso ao de dor nociceptiva convencional. Sem lesão visível.

Diagnóstico Diferencial

Deve excluir: **candidíase eritematosa** (raspado positivo, resposta ao antifúngico), **líquen plano erosivo** (estrias de Wickham visíveis), **deficiências de B12, ferro e folato** (hemograma e dosagens séricas), xerostomia sintomática e hipersensibilidade a materiais dentários.

Tratamento

Antidepressivos tricíclicos (amitriptilina, nortriptilina) em doses baixas — ação analgésica central. **Gabapentina e pregabalina** — moduladores de canais de cálcio com eficácia em dor neuropática. **Terapia cognitivo-comportamental** — abordagem de primeira linha pela forte associação com ansiedade, depressão e somatização.

Alterações do Paladar — Hipogeusia e Disgeusia

As alterações do paladar são queixas frequentes em pacientes com doenças gastrointestinais, hematológicas e em uso de polifarmácia. Impactam diretamente o prazer alimentar, a ingestão nutricional e, conseqüentemente, o estado nutricional do paciente.

Definições

- **Hipogeusia:** redução quantitativa da sensação gustativa em um ou mais sabores básicos (doce, salgado, amargo, azedo, umami)
- **Disgeusia:** alteração qualitativa do paladar — percepção distorcida dos sabores, frequentemente descrita como sabor metálico, amargo ou desagradável persistente
- **Ageusia:** ausência completa do paladar — rara, geralmente associada a lesões neurológicas
- **Fantogeusia:** percepção de sabor sem estímulo gustativo presente

Causas e Tratamento

Deficiências nutricionais:

- **Zinco:** cofator essencial para a gustina (anidrase carbônica VI), proteína presente na saliva que nutre as papilas gustativas; sua deficiência é a causa nutricional mais importante de disgeusia
- Deficiências de B12, B3 (niacina), cobre e vitamina A também afetam o paladar

Outras causas: neuropatias (diabetes, quimioterapia), medicamentos (metronidazol, captopril, metformina), radioterapia, COVID-19, xerostomia grave.

Tratamento:

- Correção da causa de base é a medida mais eficaz
- **Suplementação de zinco** (sulfato de zinco 220 mg 2x/dia) por 3–6 meses — mesmo na ausência de deficiência documentada, pode ter efeito terapêutico
- Higiene oral rigorosa e estimulação salivar

Halitose — Classificação e Fisiopatologia

A halitose é definida como a **alteração desagradável do odor do ar expirado**, sendo uma condição de enorme impacto psicossocial e qualidade de vida. Afeta 20 a 50% da população em algum momento, com prevalência de halitose crônica em torno de 25%. Sua etiologia é multifatorial e requer abordagem diagnóstica sistemática.

Halitose Fisiológica

Ocorre em condições normais — ao acordar (jejum noturno, redução do fluxo salivar), após ingestão de alimentos odoríferos (alho, cebola, álcool). Transitória e sem patologia subjacente. Abordagem: higiene oral e dieta.

Halitose Patológica

Intraoral (80–90% dos casos): **saburra lingual** é a causa principal — biofilme bacteriano espesso no dorso posterior da língua. Outras causas: doença periodontal, cáries, xerostomia, próteses mal higienizadas. Extraoral: doenças sistêmicas (DRC — odor urêmico, DM — odor cetônico, hepatopatia — odor sulfuroso), doenças respiratórias (sinusite, bronquiectasia).

Pseudo-halitose e Halitofobia

Pseudo-halitose: paciente acredita ter halitose sem confirmação objetiva — problema psicológico que requer abordagem multidisciplinar com psicólogo. Halitofobia: crença persistente de halitose mesmo após tratamento bem-sucedido — componente obsessivo-compulsivo.

Fisiopatologia — Compostos Sulfurados Voláteis (CSV)

A halitose patológica oral resulta principalmente da ação de **bactérias anaeróbias gram-negativas** (*Treponema denticola*, *Porphyromonas gingivalis*, *Fusobacterium nucleatum*) que degradam proteínas e aminoácidos sulfurados presentes na saliva, resíduos alimentares e células descamadas, produzindo **compostos sulfurados voláteis** (sulfeto de hidrogênio, metil mercaptano, dimetilsulfeto) responsáveis pelo odor desagradável característico.

Aftas — Características, Tipos e Etiologia

As aftas, ou úlceras aftosas recorrentes (UAR), são as úlceras mais comuns da mucosa oral, afetando 20 a 25% da população geral e até 50% dos familiares de primeiro grau de pacientes afetados, sugerindo componente hereditário. Caracterizam-se por ulcerações dolorosas, recorrentes e autolimitadas, com impacto significativo na qualidade de vida e, quando recorrentes ou graves, podem indicar doença sistêmica subjacente.

Aftas Menores (Mikulicz)

Tipo mais comum (75–85% dos casos).
Úlceras de **3 a 10 mm**, ovais ou redondas, com fundo amarelo-esbranquiçado e halo eritematoso. Localização preferencial em mucosa não queratinizada. Resolução em **7 a 14 dias** sem cicatriz. Recorrência variável.

Aftas Maiores (Sutton)

Úlceras de **10 mm ou mais**, profundas, com bordas elevadas e irregulares.
Duração de **4 a 6 semanas ou mais**, com cicatrização que pode deixar sequelas.
Mais dolorosas e incapacitantes. Podem acometer mucosa queratinizada.

Aftas Herpetiformes

Múltiplas úlceras pequenas (**1 a 3 mm**), que podem coalescer formando úlceras maiores irregulares. Sem relação com herpes-vírus. Mais comuns em mulheres adultas. Recorrência alta e impacto funcional significativo.

Etiologia Multifatorial

A etiopatogenia das aftas envolve interação de fatores imunológicos (disfunção de linfócitos T citotóxicos e NK), genéticos, nutricionais (deficiências de B12, ferro, folato, zinco), hormonais, microbianos e psicológicos (estresse como gatilho). Doenças sistêmicas como doença celíaca, DII, HIV e doença de Behçet devem ser investigadas em aftas graves ou resistentes ao tratamento.

Aftas — Relação com Doenças Sistêmicas e Investigação

A presença de aftas recorrentes, extensas ou refratárias ao tratamento deve sempre levantar a suspeita de doença sistêmica subjacente, especialmente em pacientes gastroenterológicos. A investigação direcionada pode revelar condições tratáveis que, uma vez corrigidas, resolvem as ulcerações.



Doença Celíaca

Aftas recorrentes como manifestação extraintestinal em até 10% dos celíacos. Frequentemente associadas a deficiências de ferro, B12 e folato por má absorção. Resolução com dieta sem glúten. **Triagem com anti-transglutaminase IgA e IgA total** deve ser realizada em aftas recorrentes.



Doenças Inflamatórias Intestinais

A doença de Crohn produz aftas orais específicas em 6–20% dos casos, frequentemente maiores e lineares. A retocolite ulcerativa pode ter aftas como manifestação extraintestinal. Aftas orais na DII frequentemente correlacionam com atividade da doença intestinal.



HIV/AIDS

Aftas graves, extensas e de difícil cicatrização são comuns na imunodeficiência. Em pacientes HIV+, aftas herpetiformes coalescentes e aftas maiores extensas indicam comprometimento imunológico avançado. Pesquisa de HIV deve ser considerada em aftas severas sem outra causa.



Investigação Laboratorial

Hemograma completo (anemia, leucopenia), **ferro sérico**, **ferritina**, **B12**, **folato** (deficiências nutricionais), **anti-transglutaminase IgA e IgA total** (doença celíaca), **anti-HIV**, **zinco sérico**, hemossedimentação e PCR (atividade inflamatória sistêmica).

Tratamento das Aftas

Tratamento Inicial — Casos Leves a Moderados

O objetivo primário é o alívio da dor e a aceleração da cicatrização:

- **Anestésicos tópicos:** lidocaína a 2% gel ou benzocaína — aplicação local antes das refeições para permitir alimentação adequada
- **Corticoides tópicos:** acetonida de triancinolona 0,1% em orabase, clobetasol 0,05% gel ou dexametasona elixir — reduzem inflamação local, dor e duração das lesões
- **Enxaguatórios antissépticos:** clorexidina 0,12% reduz colonização bacteriana secundária e melhora o conforto
- **Laser de baixa potência:** acelera cicatrização e reduz dor; recurso disponível em centros especializados
- **Correção de deficiências:** suplementação de B12, ferro, folato e zinco quando deficiência documentada

Tratamento de Casos Graves e Refratários

- **Corticoides sistêmicos:** prednisona 0,5–1 mg/kg/dia em ciclos curtos para aftas maiores extensas — indicado quando há comprometimento funcional grave (impossibilidade de alimentação)
- **Talidomida:** altamente eficaz para aftas graves e recorrentes; uso restrito pela teratogenicidade — proibido em mulheres em idade fértil sem contracepção rigorosa; eficaz também nas aftas da doença de Behçet e do HIV
- **Colchicina:** 0,5–1,5 mg/dia — ação anti-inflamatória sem imunossupressão sistêmica; boa opção para profilaxia em casos recorrentes
- **Dapsona, pentoxifilina e imunossupressores** (azatioprina, metotrexato): reservados para casos refratários a outras terapias

❏ Em aftas graves refratárias, reavalie sempre a possibilidade de doença sistêmica não diagnosticada antes de escalar o tratamento.

Doença de Behçet

A doença de Behçet (DB) é uma **vasculite sistêmica multifocal** de etiologia desconhecida, caracterizada por recorrência de úlceras orais e genitais, uveíte e manifestações cutâneas, vasculares, articulares e neurológicas. Associada ao antígeno HLA-B51, predomina em populações ao longo da antiga "Rota da Seda" (Turquia, Irã, Japão) e é rara no Brasil.

Critérios Diagnósticos (ISG, 1990)

Obrigatório: úlceras orais recorrentes (≥3 episódios em 12 meses)

Mais pelo menos 2 dos seguintes:

- **Úlceras genitais recorrentes:** aftas genitais típicas, dolorosas
- **Lesões oculares:** uveíte anterior ou posterior, vasculite retiniana
- **Lesões cutâneas:** eritema nodoso, pseudofoliculite, lesões acneiformes
- **Teste de patergia positivo:** pápula eritematosa ≥2mm após 48h da punção com agulha estéril (especificidade alta em populações orientais)

Manifestações Gastroenterológicas e Tratamento

O trato gastrointestinal é acometido em 3–50% dos casos (maior prevalência em pacientes japoneses e coreanos). **Úlceras ileocecais** são as mais comuns, podendo mimetizar doença de Crohn, levando a diagnóstico errôneo. Perfuração intestinal é complicação grave e potencialmente fatal.

Tratamento

- **Colchicina:** tratamento de primeira linha para aftas orais e genitais e eritema nodoso
- **Corticoides:** para exacerbações agudas e manifestações graves
- **Imunossupressores:** azatioprina, ciclosporina — para manifestações oculares e neurológicas
- **Agentes biológicos:** infliximabe, adalimumabe — para casos refratários, especialmente com acometimento ocular e gastrointestinal grave

Gengivite Ulcerativa Necrosante

A Gengivite Ulcerativa Necrosante (GUN), anteriormente denominada "boca de trincheira" ou "angina de Vincent", é uma infecção aguda grave das estruturas periodontais, caracterizada por **necrose das papilas interdentais**, dor intensa, sangramento gengival espontâneo e halitose pronunciada. Associa-se quase invariavelmente a estados de imunossupressão ou comprometimento sistêmico grave.

Fatores Predisponentes

- **Infecção pelo HIV:** principal associação na atualidade — a GUN pode ser o evento inaugural definidor de AIDS
- **Desnutrição grave:** especialmente proteico-calórica; comum em países em desenvolvimento e em pacientes hospitalizados
- **Tabagismo:** fator de risco independente, reduz a resposta imune local
- **Estresse psicológico intenso:** inicialmente descrita em soldados em trincheiras — daí o nome histórico
- **Higiene oral precária** e doença periodontal preexistente

Quadro Clínico e Tratamento

Triade clássica: úlcero-necrose das papilas interdentais (papilas "decapitadas"), dor gengival intensa e halitose fétida característica. Pode progredir para Periodontite Ulcerativa Necrosante e Estomatite Ulcerativa Necrosante — formas de gravidade crescente.

Tratamento:

1. **Debridamento suave** com curetas, remoção de tecido necrótico sob anestesia local
2. **Antibióticos sistêmicos:** metronidazol 400 mg 3x/dia por 5–7 dias (primeira escolha); amoxicilina como alternativa
3. **Enxaguatórios** com clorexidina 0,12% 2x/dia
4. Investigação e tratamento da condição sistêmica predisponente — **teste anti-HIV obrigatório**

Introdução às Lesões Pré-Malignas Oraís

As lesões pré-malignas orais representam alterações da mucosa com **risco aumentado de transformação em carcinoma espinocelular oral** — o câncer de boca mais comum, responsável por expressiva morbimortalidade. O diagnóstico precoce dessas lesões e seu manejo adequado são a estratégia mais eficaz de prevenção do câncer oral.

5–7%

Transformação Geral

Taxa média de transformação maligna de leucoplasias orais por 10 anos — varia amplamente conforme características clínicas e histológicas

60%

Eritroplasia

Taxa de displasia severa ou carcinoma in situ no momento da biópsia de eritroplasias — lesão de muito alto risco, subestimada na prática clínica

300K

Casos Anuais

Novos casos de câncer oral no mundo a cada ano, com maioria em países de baixa e média renda, relacionados ao tabaco e álcool

1ª

Ferramenta Preventiva

O exame rotineiro da mucosa oral pelo clínico é a primeira e mais importante ferramenta de detecção precoce do câncer oral

O reconhecimento das lesões pré-malignas exige familiaridade com suas características clínicas, capacidade de identificar fatores de risco (tabaco, álcool, HPV 16/18) e decisão criteriosa sobre quando biopsar. Todo profissional de saúde que realiza exame físico deve incluir o exame sistemático da cavidade oral em sua rotina.

Leucoplasia Oral

A leucoplasia é definida pela OMS como "**placa branca de risco questionável, excluídas outras doenças conhecidas ou distúrbios que não apresentem risco aumentado para câncer**" — ou seja, é um diagnóstico de exclusão, estabelecido após afastar todas as causas de placa branca com etiologia conhecida (candidíase, queratose friccional, líquen plano, etc.).

Características Clínicas

- **Aspecto:** placa branca ou branco-acinzentada, de superfície que pode ser homogênea (lisa, uniforme) ou não-homogênea (verrucosa, nodular, eritroleucoplásica)
- **Consistência:** não removível à raspagem — critério fundamental de diferenciação da candidíase pseudomembranosa
- **Localização:** qualquer sítio da mucosa oral; as lesões em assoalho bucal, ventre lingual e palato mole têm maior risco de malignização
- **Sintomas:** geralmente assintomática; dor ou ulceração numa leucoplasia são sinais de alerta para transformação maligna

Fatores de Risco para Malignização

Leucoplasias não-homogêneas (especialmente eritroleucoplásicas), localização em assoalho, ventre lingual e mucosa jugal posterior, tamanho $>200\text{mm}^2$, displasia moderada a severa, infecção por HPV de alto risco, tabagismo associado ao álcool.

Conduta — Algoritmo Prático

1. **Identificar e remover fatores causais:** cessar tabaco e álcool, corrigir trauma local, tratar candidíase se suspeita
2. **Reavaliação em 2–4 semanas:** se a lesão regredir → confirmação de queratose friccional ou candidíase; se persistir → continuar investigação
3. **Biópsia incisional obrigatória** em toda leucoplasia persistente após remoção dos fatores causais — representativa da área mais suspeita (mais eritematosa, nodular ou ulcerada)
4. **Resultado da biópsia:**
 - Sem displasia → acompanhamento semestral
 - Displasia leve → acompanhamento trimestral
 - Displasia moderada a severa/CIS → tratamento (excisão cirúrgica, laser CO_2)

❏ Toda leucoplasia que não regride após 2–4 semanas da remoção dos fatores causais DEVE ser biopsiada — sem exceção.

Síntese — Parte I: Doenças Orais e Gastroenterologia

Esta primeira parte da apostila percorreu o espectro das principais condições orais de interesse gastroenterológico, desde variantes normais até lesões com potencial maligno. O fio condutor é a **cavidade oral como espelho da saúde sistêmica** — uma janela diagnóstica que o gastroenterologista deve aprender a utilizar.



Reconhecer

Diferenciar achados normais e patológicos

Investigar

Avaliar correlações sistêmicas e deficiências

Gerir

Tratar causa, referir e acompanhar

Reconhecer

Variantes normais, transtornos funcionais, úlceras, lesões brancas e pigmentadas — a identificação correta evita diagnósticos equivocados e biópsias desnecessárias.

Correlacionar

DII, doença celíaca, Sjögren, deficiências nutricionais, HIV, Behçet — cada lesão oral pode ser a chave para diagnósticos sistêmicos que impactam o manejo gastroenterológico.

Manejar

Tratamento tópico, sistêmico, encaminhamento ao estomatologista ou cirurgião, biópsia oportuna — a conduta correta na lesão oral correta salva vidas, especialmente nas pré-malignas.